入院记录
姓名：ＸＸＸ　性别：男　年龄：５６岁
主诉：反复胸痛1月余。
现病史：患者1月前无明显诱因出现胸痛，活动后加重，休息数分钟可缓解，无放射痛，无大汗、恶心。曾于
既往史：高血压病史8年，最高血压１５５／９２ｍｍＨｇ，长期口服降压药。否认糖尿病。
个人史：吸烟２０年，每日１０支。
体格检查：Ｔ３６．５℃，Ｐ７２次/分，Ｒ１８次/分，ＢＰ１４８／９０ｍｍＨｇ。神志清，双肺呼吸音
辅助检查：心电图：窦性心律，ＳＴ－Ｔ改变。
初步诊断：冠心病，不稳定型心绞痛；高血压2级。
诊疗计划：完善冠脉ＣＴＡ、心肌酶、血脂；抗血小板、调脂、扩冠治疗。

入院记录
姓名：ＸＸＸ　性别：男　年龄：５６岁
主诉：反复胸痛1月余。
现病史：患者1月前无明显诱因出现胸痛，活动后加重，休息数分钟可缓解，无放射痛，无大汗、恶心。曾于
既往史：高血压病史8年，最高血压１５５／９２ｍｍＨｇ，长期口服降压药。否认糖尿病。
个人史：吸烟２０年，每日１０支。
体格检查：Ｔ３６．５℃，Ｐ７２次/分，Ｒ１８次/分，ＢＰ１４８／９０ｍｍＨｇ。神志清，双肺呼吸音
辅助检查：心电图：窦性心律，ＳＴ－Ｔ改变。
初步诊断：冠心病，不稳定型心绞痛；高血压2级。
诊疗计划：完善冠脉ＣＴＡ、心肌酶、血脂；抗血小板、调脂、扩冠治疗。

入院记录
姓名：ＸＸＸ　性别：男　年龄：５６岁
主诉：反复胸痛1月余。
现病史：患者1月前无明显诱因出现胸痛，活动后加重，休息数分钟可缓解，无放射痛，无大汗、恶心。曾于
既往史：高血压病史8年，最高血压１５５／９２ｍｍＨｇ，长期口服降压药。否认糖尿病。
个人史：吸烟２０年，每日１０支。
体格检查：Ｔ３６．５℃，Ｐ７２次/分，Ｒ１８次/分，ＢＰ１４８／９０ｍｍＨｇ。神志清，双肺呼吸音
辅助检查：心电图：窦性心律，ＳＴ－Ｔ改变。
初步诊断：冠心病，不稳定型心绞痛；高血压2级。
诊疗计划：完善冠脉ＣＴＡ、心肌酶、血脂；抗血小板、调脂、扩冠治疗。

入院记录
姓名：ＸＸＸ　性别：男　年龄：５６岁
主诉：反复胸痛1月余。
现病史：患者1月前无明显诱因出现胸痛，活动后加重，休息数分钟可缓解，无放射痛，无大汗、恶心。曾于
既往史：高血压病史8年，最高血压１５５／９２ｍｍＨｇ，长期口服降压药。否认糖尿病。
个人史：吸烟２０年，每日１０支。
体格检查：Ｔ３６．５℃，Ｐ７２次/分，Ｒ１８次/分，ＢＰ１４８／９０ｍｍＨｇ。神志清，双肺呼吸音
辅助检查：心电图：窦性心律，ＳＴ－Ｔ改变。
初步诊断：冠心病，不稳定型心绞痛；高血压2级。
诊疗计划：完善冠脉ＣＴＡ、心肌酶、血脂；抗血小板、调脂、扩冠治疗。

入院记录
姓名：ＸＸＸ　性别：男　年龄：５６岁
主诉：反复胸痛1月余。
现病史：患者1月前无明显诱因出现胸痛，活动后加重，休息数分钟可缓解，无放射痛，无大汗、恶心。曾于
既往史：高血压病史8年，最高血压１５５／９２ｍｍＨｇ，长期口服降压药。否认糖尿病。
个人史：吸烟２０年，每日１０支。
体格检查：Ｔ３６．５℃，Ｐ７２次/分，Ｒ１８次/分，ＢＰ１４８／９０ｍｍＨｇ。神志清，双肺呼吸音
辅助检查：心电图：窦性心律，ＳＴ－Ｔ改变。
初步诊断：冠心病，不稳定型心绞痛；高血压2级。
诊疗计划：完善冠脉ＣＴＡ、心肌酶、血脂；抗血小板、调脂、扩冠治疗。

入院记录
姓名：ＸＸＸ　性别：男　年龄：５６岁
主诉：反复胸痛1月余。
现病史：患者1月前无明显诱因出现胸痛，活动后加重，休息数分钟可缓解，无放射痛，无大汗、恶心。曾于
既往史：高血压病史8年，最高血压１５５／９２ｍｍＨｇ，长期口服降压药。否认糖尿病。
个人史：吸烟２０年，每日１０支。
体格检查：Ｔ３６．５℃，Ｐ７２次/分，Ｒ１８次/分，ＢＰ１４８／９０ｍｍＨｇ。神志清，双肺呼吸音
辅助检查：心电图：窦性心律，ＳＴ－Ｔ改变。
初步诊断：冠心病，不稳定型心绞痛；高血压2级。
诊疗计划：完善冠脉ＣＴＡ、心肌酶、血脂；抗血小板、调脂、扩冠治疗。